

胃溃疡患者应注意药物相互作用

一、甲氰咪胍忌胃复安

有的胃溃疡患者犯病时有恶心、呕吐症状,大多数人在服用甲氰咪胍止痛、抗酸的同时,自己又服用胃复安片止吐,结果呕吐有所好转,但胃酸又增加,病情不见好转,这是因为胃复安可以抑制人体延脑的催吐化学感受区,止吐效果确实很好,但它能降低甲氰咪胍在胃肠道的吸收,这样甲氰咪胍就不能达到预期的血药浓度,也就不能很好地抑制胃酸分泌,达不到治疗目的。所以如把甲氰咪胍与胃复安合用,应该增加甲氰咪胍的剂量。

二、甲氰咪胍忌硫酸亚铁

有的胃溃疡患者患病已十多年了,又有贫血的症状,就在服用甲氰咪胍治疗溃疡的同时,又服用硫酸亚铁抗贫血治疗,经过6周以后,胃溃疡和贫血均未见明显起色,这是因为抗贫血药硫酸亚铁、枸橼酸铁胺等必须处于酸性环境中才能被人体吸收、利用,才能使血色素增高、红细胞增多。而甲氰咪胍能降低胃液酸度,使铁吸收减少,抗贫血效果当然不会好;铁制剂对溃疡面又有刺激作用,也就影响了胃溃疡的愈合,所以应将此

二药分开单独服用。在服用硫酸亚铁时加上保护胃的措施,两种病才能慢慢治好。

三、甲氰咪胍忌阿斯匹林

有的胃溃疡患者服用甲氰咪胍治疗溃疡时,风湿性关节炎又犯了,这些患者就把阿斯匹林与甲氰咪胍同时服用,但服用6周后胃溃疡未见明显好转。原来,甲氰咪胍也叫西米替丁,属于组织胺 H_2 -受体阻断药,它治疗胃溃疡的主要作用在于抑制胃酸的分泌,减少胃酸对已经形成溃疡面粘膜的刺激,从而有利于胃粘膜的修复,促进溃疡的愈合。由于阿斯匹林属于酸性药,可以增加胃内的酸度,与阿斯匹林同服就使甲氰咪胍抑制胃酸分泌的作用被抵消,胃仍处于高酸环境中,溃疡面得不到保护,因而影响了胃溃疡的治疗。另外甲氰咪胍可以提高胃内的pH值,使阿斯匹林的溶解度增大,吸收增多,可使血药浓度提高。如果阿斯匹林服用量较大,就容易出现中毒反应。

四、甲氰咪胍忌普鲁卡因胺

胃溃疡患者服用甲氰咪胍,后又发现有“室性早搏”,就按医嘱服用普鲁卡

因胺片,在治疗过程中,病人有心动过缓和精神忧郁等症状。这是因为甲氰咪胍是一种 H_2 -受体拮抗剂,它通过抑制胃酸分泌来治疗消化性溃疡效果肯定,但是这种药可减少普鲁卡因胺及其主要代谢产物在肾脏的排泄,使其血浓度升高,合用时应减少普鲁卡因胺的用量。此外,洋地黄毒甙、美多心安、心得安、奎尼丁、利多卡因、苯妥英钠、吗啡、华法令等药均可因同服甲氰咪胍增加血药浓度而引起中毒。所以,这些药都不应与甲氰咪胍一起服用。

五、甲氰咪胍忌氧化镁

有些患者知道溃疡病是由胃酸刺激所致,治病心切,在遵医嘱服用甲氰咪胍抑制胃酸分泌,保护溃疡面的同时,自己又到药店买了氧化镁片口服来中和胃酸。认为这样可能效果会更快。结果服药一个月后溃疡愈合并不理想。它们有一个共同特点,就是不能和氧化镁、氢氧化铝同时服用,因为这些药物可以抑制吸收,这样血中便达不到有效治疗,影响了治疗效果。

(马玉梅)

消化性溃疡与胃癌

消化性溃疡根据生长部位可分为胃溃疡和十二指肠溃疡,是由于幽门螺旋杆菌(Hp)感染造成持续高胃酸进入胃及十二指肠,发生局部炎症、糜烂,产生微循环障碍导致溃疡。绝大多数非药物诱导的十二指肠溃疡与Hp有关,根除Hp可使胃十二指肠粘膜的炎症改变、消退,可几乎永久性地治愈溃疡;而胃溃疡则较为复杂,慢性胃炎、胃溃疡、胃癌之间有转变和引发的可能,真正与Hp相关的胃溃疡正在变得少见。

胃溃疡可以癌变,但胃溃疡癌变的机会会有多少,胃溃疡发生癌变的机率一般不超过5%,慢性萎缩性胃炎发展成胃癌的机率大约为1%,所以,实际上胃溃疡

变成胃癌的机会并不大。不过胃癌可以在癌瘤的基础上发生溃疡,这种由胃癌形成的溃疡不论用X线检查或胃镜观察有时从外形上看都很难与良性胃溃疡区别。把这种癌性溃疡当作良性胃溃疡而延误诊治的实例确实不少。所以对一切胃溃疡都要提高警惕,患者要请有经验的医生看一看,一定要用胃镜检查,在胃镜观察下还要在病变部位取活组织检查。

十二指肠溃疡和胃溃疡的临床特点和发病原因不完全相同。上面说到胃溃疡有少数可转变为胃癌,对生长在十二指肠的良性溃疡,全世界还没有发现有自身转变成癌的病例。而且,发生在十

二指肠球部的恶性肿瘤也十分罕见,所以,患有十二指肠溃疡的患者不必担心溃疡会癌变。但并不是说得了十二指肠溃疡不会同时得胃癌。医学家认为,在同时一人中十二指肠溃疡与胃癌并存十分少见,因此,当十二指肠溃疡同时有胃溃疡时,一般都认为是良性溃疡而不去注意,这就容易忽视有少数十二指肠溃疡可能与胃癌并存,胃溃疡由胃癌引起。所以,碰到这种情况时,对胃中的溃疡或可疑病变还是应该在胃镜观察下取活组织检查,以排除胃癌可能,并应在治疗后再作胃镜复查,观察溃疡是否完全愈合,以确保安全。

(杜昆)